

Progress Test 2023

1 Depuis quatre semaines, un fumeur de 59 ans note la présence d'un ulcère indolore de 3x13 mm siégeant au niveau du plancher buccal droit. La palpation cervicale révèle la présence de 2 nodules sous-angulo-mandibulaires droit centimétriques indolores et mobiles. L'hémogramme, la protéine C-réactive et la vitesse de sédimentation globulaire sont normaux, de même que la radiographie des poumons.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Tuberculose
- b. Syphilis
- c. Mononucléose infectieuse
- d. Stomatite aphteuse
- e. Carcinome du plancher buccal

2 Une cavalière de 33 ans a fait une grave chute de cheval. À l'arrivée du médecin urgentiste, la patiente a un score de Glasgow de 14/15 et elle est stable sur le plan hémodynamique. La radiographie effectuée ne montre pas d'hémothorax ni de pneumothorax. L'ultrason abdominal est sans particularité. Deux jours plus tard, une tachycardie avec hypotension s'installe de manière aiguë, accompagnée d'une chute de l'Hémoglobine.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Rupture diaphragmatique non diagnostiquée au départ
- b. Rupture de la rate en deux temps
- c. Hémorragie intrahépatique
- d. Contusion pancréatique
- e. Hémorragie digestive haute

3 Q: Quel est l'aspect radiologique typique d'une sarcoïdose sur un cliché thoracique ?

- a. Lymphadénopathie biliaire
- b. Infiltrats diffus

- c. Lésions cicatricielles et épaissement fibreux
- d. Nodule expansif

4 Un patient hospitalisé en neurologie délaisse toujours une partie de son repas, semblant ignorer la moitié gauche du plateau. De même, il ne remarque pas les personnes qui se trouvent à sa gauche et, lorsqu'on lui présente une tâche de recherche, il ne voit pas du tout les stimuli cibles se trouvant sur le côté gauche de la feuille. Son champ visuel est normal.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Extinction visuelle
- b. Hémianopsie latérale homonyme
- c. Héli-négligence
- d. Agnosie visuelle

5 Une fille de 6 ans vous consulte au cabinet pour des lésions cutanées érythémateuses surélevées et très prurigineuses au niveau des plis des coudes et des genoux. On note la présence d'un dermatographe blanc.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Dermatite atopique
- b. Candidose
- c. Lichen ruber
- d. Psoriasis

6 Une étudiante de 24 ans se dit déprimée, sans intérêt et incapable de se lever le matin. Elle n'a pas rendu de devoirs importants et ne s'est pas inscrite aux examens dans les délais. Cette période a été précédée d'une autre où elle était très excitée et travaillait des nuits entières. D'un jour à l'autre, l'intérêt et l'énergie ont soudainement disparu.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Trouble affectif bipolaire
- b. Épisode dépressif
- c. Schizophrénie catatonique
- d. Dépendance à la cocaïne

- e. Épisode maniaque
- f. Sclérose en plaques
- g. Schizophrénie paranoïde
- h. Trouble schizo-affectif
- i. Lymphome du SNC

7 Les parents d'un enfant de 8 ans ont remarqué depuis peu de moins bons résultats scolaires. Ils ont noté qu'elle semble absente et rêveuse, surtout le matin. Dans les cahiers scolaires, il manque régulièrement des mots, des syllabes ou des phrases entières.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Absence épileptique
- b. Trouble du spectre de l'autisme
- c. Observations typiques
- d. Syndrome cérébral organique à évolution progressive

8 Un patient de 61 ans connu pour une hypertension artérielle est admis aux urgences. Le patient a été pris d'une violente douleur rétrosternale d'apparition brutale, avec irradiation entre les omoplates. L'examen révèle une tachycardie sinusale, la pression artérielle est de 175/90 mmHg.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Pancréatite aiguë
- b. Anévrisme disséquant de l'aorte
- c. Embolie pulmonaire foudroyante
- d. Infarctus de la paroi inférieure
- e. Rupture diaphragmatique

9 Une architecte de 29 ans présente depuis plusieurs mois une vision double et d'une ptose palpébrale se majorant au cours de la journée ainsi que de difficultés à déglutir le soir.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Encéphalomyélite disséminée
- b. Myasthénie

- c. Démence vasculaire sous-corticale
- d. Glioblastome
- e. Atrophie multisystémique

10 Un footballeur de 27 ans se blesse au genou pendant l'entraînement. Vous examinez le sportif et constatez une incapacité d'extension active au niveau de l'articulation du genou. La radiographie de profil montre une ascension de la rotule.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Rupture isolée du ligament croisé antérieur
- b. Déchirure du retinaculum patellaire
- c. Lésion du ligament croisé postérieur
- d. Déchirure du ligament patellaire

11 Un jeune homme de 21 ans est amené aux urgences par les ambulanciers au petit matin. Il semble somnolent, avec un score de 8/15 sur l'échelle de Glasgow, et respire de manière anormalement profonde et laborieuse avec une fréquence respiratoire de 25/min. La saturation, la pression artérielle et la fréquence cardiaque sont dans la norme. La gazométrie veineuse montre les paramètres suivants : pH 6.9 ; pCO₂ 21 mmHg ; pO₂ 360 mmHg ; HCO₃ 5.5 mmol/l, lactates 3 mmol/l, glucose 45 mmol/dl, Na 132 mmol/l, K 7.7 mmol/l, Cl 103 mmol/l. (Normes : pH 7.35-7.45, pCO₂ 35-45 mmHg, pO₂ 73-103 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/l, lactates 0.6-1.7 mmol/l, glucose 3.7-5.6 mmol/l, Na 135-145 mmol/l, K 3.5-4.6 mmol/l, Cl 98-110 mmol/l)

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Intoxication à l'éthylène-glycol
- b. Cétoacidose
- c. Acidose lactique
- d. Intoxication à la metformine
- e. Syndrome urémique

12 Q: Quelle pathologie internistique entraîne le plus souvent des complications au niveau du pied ?

- a. Hépatite
- b. **Diabète sucré**
- c. Gastrite chronique
- d. Hémophilie

13 Q: À quoi l'asthme bronchique chez l'enfant est-il le plus souvent associé ?

- a. **Réactions immédiates IgE-dépendantes déclenchées par des pneumallergènes**
- b. Trouble ventilatoire restrictif réversible
- c. Altération de l'immunité cellulaire
- d. Insuffisance pancréatique exocrine

14 Q: Quelle est la localisation typique d'une tendinite calcifiante ?

- a. **Coiffe des rotateurs de l'épaule**
- b. Tendons extenseurs des doigts
- c. Épicondyles de l'humérus
- d. Tendon rotulien de l'articulation du genou
- e. Insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum

15 Une femme de 46 ans souffre de céphalées soudaines et intenses. Pendant l'un de ces épisodes, sa pression artérielle est de 190/115 mmHg. Sa pression artérielle normale est de 130/90 mmHg. Sa sœur a connu des épisodes similaires il y a quelques années. On retrouve des concentrations élevées de métanéphrines plasmatiques. Vous suspectez une tumeur.

Q: laquelle des substances suivantes est la plus susceptible d'être sécrétée par cette tumeur ?

- a. ACTH
- b. Aldostérone
- c. **Adrénaline**
- d. Cortisol
- e. Rénine

16 Q: Quel est le symptôme typique de la présence d'un syndrome L5 ?

- a. Aréflexie rotulienne
- b. Aréflexie achilléenne
- c. Parésie du muscle long extenseur de l'hallux
- d. Déficit sensitif au niveau du bord latéral du pied

17 Une primipare de 35 ans, à 34 semaines de grossesse, signale des douleurs épigastriques. Elle présente en même temps une hypertension artérielle (160/100 mmHg, norme : 120-80 mmHg).

Q: Laquelle des suspicions diagnostiques suivantes est la plus probable ?

- a. Cholestase gravidique
- b. Ulcère duodénal
- c. Calculs biliaires
- d. HELLP syndrome
- e. Varices œsophagiennes

18 Q: Laquelle des tumeurs ci-dessous donne le plus fréquemment des métastases dans les ganglions lymphatiques cervicaux ?

- a. Carcinome de l'hypopharynx
- b. Carcinome colorectal
- c. Lymphome de la parotide
- d. Carcinome des cordes vocales
- e. Papillome inversé

19 Un homme de 40 ans, alcoolique et grand fumeur, est admis à l'hôpital pour de fortes douleurs épigastriques avec irradiation en ceinture et des nausées.

Q: Au vu de l'anamnèse, quelle est le diagnostic le plus probable ?

- a. Ulcère gastrique
- b. Pancréatite
- c. Infarctus du myocarde
- d. Colite ulcéreuse
- e. Dissection aortique

20 Q: Quelle est la localisation la plus susceptible d'une parésie aiguë de l'hémicorps droit, caractérisée par une prédominance au niveau du bras et du nerf facial et accompagnée de troubles du langage ?

- a. Lobe occipital droit
- b. Lobe occipital gauche
- c. Région pinéale
- d. Capsule interne droite
- e. Capsule interne gauche

21 Lors d'une échographie réalisée chez une patiente de 30 ans, on découvre de manière fortuite une nette différence de taille entre les deux reins. Vous souhaitez maintenant évaluer la fonction relative de chaque rein.

Q: Quelle est la méthode de choix ?

- a. Détermination de la clairance de la créatinine
- b. Scintigraphie rénale dynamique
- c. Angiographie des vaisseaux rénaux de chaque côté
- d. Écho-Doppler couleur des reins
- e. Urographie intraveineuse

22 Une jeune femme de 26 ans est tombée sur la main gauche en jouant au volley-ball. Elle ressent une douleur dans la région distale entre les tendons des muscles long et court extenseurs du pouce (tabatière anatomique).

Q: Lequel des os du carpe suivants est le plus susceptible d'être fracturé ?

- a. Os scaphoïde
- b. Os lunatum
- c. Os triquétrum
- d. Os pisiforme
- e. Os trapèze
- f. Os trapézoïde
- g. Os capitatum
- h. Os hamatum

23 Pour la transfusion de globules rouges, on utilise aujourd'hui exclusivement des concentrés érythrocytaires déleucocytés. La déleucocytation de ces préparations a lieu avant tout pour éviter la transmission d'agents pathogènes.

Q: Lequel des agents pathogènes suivants est le plus concerné dans ce contexte ?

- a. Cytomégalovirus (CMV)
- b. Virus de l'hépatite B
- c. Virus de l'hépatite C
- d. Treponema pallidum

24 Un employé d'une station d'épuration de 46 ans, en bonne santé habituelle, tombe brutalement malade avec de violentes céphalées et douleurs dans les membres, en particulier dans les muscles du mollet, ainsi qu'une fièvre atteignant 40 °C (norme : 36-37.4 °C). Deux jours plus tard, il est hospitalisé dans un état de conscience altérée, avec un ictère marqué et une insuffisance rénale. Il n'est pas allé à l'étranger depuis plus de six mois.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Hépatite virale aiguë fulminante
- b. Fièvre hémorragique d'origine virale
- c. Leptospirose

25 Un couple marié souffre d'un désir d'enfant inassouvi depuis cinq ans. Le traitement d'infertilité suivi depuis deux ans est inefficace. On trouve que l'infertilité de ce couple résulte d'une oligoasthénozoospermie, qui est un trouble de la fertilité masculine.

Q: Quel est le traitement le plus prometteur ?

- a. Traitement de stimulation ovarienne du 5^e au 9^e jour du cycle
- b. Injection de spermatozoïdes dans le cytoplasme de l'ovule
- c. Introduction d'un spermatozoïde dans la membrane pellucide
- d. Introduction de spermatozoïdes et d'ovules directement dans la trompe de Fallope

26 Une patiente de 30 ans, porteuse d'un stérilet, a eu ses dernières règles il y a six semaines et est admise à l'hôpital avec des douleurs pelviennes droites et des saignements vaginaux. Le test de grossesse est positif, mais il n'y a pas de sac

gestationnel intra-utérin visible à l'échographie. Dans le cul-de-sac de Douglas, on trouve peu de liquide libre.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Avortement incomplet
- b. Grossesse extra-utérine
- c. Persistance du corps jaune
- d. Appendicite

27 Un homme de 46 ans se présente au cabinet d'urologie en raison d'une masse testiculaire non douloureuse qui augmente de volume. Sur la base des résultats de l'échographie, une orchidectomie est effectuée ; une tumeur testiculaire est confirmée.

Q: Laquelle des tumeurs citées ci-dessous est la plus fréquente dans la tranche d'âge décrite ?

- a. Tumeur du sinus endodermique
- b. Carcinome chorionique
- c. Séminome
- d. Tumeur à cellules de Leydig
- e. Lymphome non hodgkinien du testicule

28 **Q: Quel est le symptôme cardinal d'une otite externe ?**

- a. Acouphène
- b. Surdit 
- c. Vertiges
- d. Douleur   la pression du tragus
- e. Fistule

29 Chez un patient comateux, vous notez une respiration tr s profonde   fr quence normale.

Q: Quelle est la cause la plus probable de ce coma ?

- a. Coma hypoglyc mique
- b. Coma diab tique
- c. Intoxication alcoolique l g re
- d. Intoxication aux barbituriques
- e. Coma myxo d mateux

30 Une patiente de 32 ans (taille : 1.60 m, poids : 72 kg) vous consulte pour une aggravation d'un gonflement bilatéral du visage. Elle vous signale également les symptômes suivants : prise pondérale de 10 kg au cours de l'année passée, hyperlipidémie d'apparition nouvelle, voix de plus en plus rauque, sensibilité accrue au froid et manque d'élan vital.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Hypothyroïdie
- b. Lymphœdème
- c. Syndrome métabolique
- d. Syndrome de Cushing
- e. Syndrome néphrotique

31 L'examen du fond d'œil chez un diabétique met en évidence, entre autres, des nodules cotonneux.

Q: Quel est le stigmate histopathologique de ces modifications ?

- a. Un œdème extracellulaire de la rétine sensorielle
- b. Un infarctus ischémique au niveau de la couche des fibres nerveuses
- c. Un œdème au niveau de la couche nucléaire externe
- d. Une hémorragie rétinienne

32 Un patient adulte, de poids normal, émet un volume urinaire de 350 ml/jour.

Q: Comment qualifier ce volume ?

- a. Anurie
- b. Oligurie
- c. Diurèse normale
- d. Polyurie

33 Une femme de 56 ans atteinte d'une maladie grave et incurable informe sa médecin qu'elle ne souhaite pas de traitement chirurgical. Elle est capable de discernement et comprend que la chirurgie est le seul traitement palliatif efficace contre sa maladie et que, sans chirurgie, elle mourra bientôt. Elle craint toutefois les effets négatifs d'une opération et affirme avoir mené une vie longue et heureuse. Deux semaines plus tard, elle tombe dans le coma et son mari demande que l'opération soit pratiquée.

Q: Lequel des facteurs suivants la médecin devrait-elle principalement prendre en compte dans sa décision de pratiquer l'opération demandée ?

- a. L'âge de la patiente
- b. La demande du mari
- c. Les souhaits exprimés précédemment par la patiente
- d. La qualité de vie de la patiente
- e. L'indication médicale

34 Q: Quel est le traitement le plus approprié d'une septicémie sur hydronéphrose aiguë ?

- a. Néphrectomie
- b. Pose de stents urétéraux
- c. Administration de concentrés plaquettaires
- d. Administration d'une fluoroquinolone

35 Trois jours après une opération, une femme de 59 ans développe un œdème du membre inférieur droit à l'hôpital. L'échographie Doppler montre une thrombose veineuse profonde. L'examen du dossier de la patiente révèle qu'aucune prophylaxie thromboembolique n'a été mise en place en périopératoire.

Q: Laquelle des mesures suivantes est la plus efficace pour éviter un tel événement indésirable à l'avenir ?

- a. Organiser une formation infirmière sur la prophylaxie thromboembolique
- b. Développer une directive institutionnelle avec des instructions standardisées pour la prophylaxie thromboembolique
- c. Promouvoir une mobilisation précoce pendant la phase postopératoire
- d. Prescrire de l'héparine de bas poids moléculaire à tous les patients postopératoires
- a. Je ne sais pas la réponse

36 Vous recevez une patiente de 7 ans dans le cadre de votre consultation pédiatrique. La mère de l'enfant vous signale que sa fille souffre depuis un certain temps de céphalées, de vertiges et de fréquents saignements de nez. À l'examen physique, vous constatez des pieds très froids. Le pouls pédieux est absent des deux côtés. Vous auscultez un souffle télésystolique au niveau infra-

claviculaire et entre les omoplates. La fillette a une pression systolique de 170 mmHg.

Q: Quel est le diagnostic préliminaire sur la base duquel les investigations diagnostiques doivent être planifiées ?

- a. Communication interventriculaire isolée (CIV) avec shunt droite-gauche
- b. Communication interauriculaire (CIA) de type ostium secundum
- c. Sténose supra-valvulaire pulmonaire
- d. Coarctation de l'aorte
- e. Tronc artériel commun

37 L'échographie d'un rein montre un bassin hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Calcul coralliforme
- b. Carcinome rénal
- c. Tumeur du bassin rénal
- d. Kyste rénal

38 Une gastroscopie de contrôle est réalisée chez un patient de 61 ans suivi pour un œsophage de Barrett. L'examen met en évidence une lésion unique à 36 cm de l'arcade dentaire, qui est enlevée par endoscopie. L'analyse histologique révèle un adénocarcinome bien différencié n'infiltrant que très superficiellement la sous-muqueuse sans invasion lympho-vasculaire, réséqué en totalité (R0).

Q: Quel est le meilleur traitement ?

- a. Radiochimiothérapie définitive
- b. Traitement multimodal : chimiothérapie systémique périopératoire + résection œsophagienne thoraco-abdominale mini-invasive avec pull-up gastrique
- c. Chimiothérapie palliative systémique
- d. Bilans de contrôle

39 On vous présente aux urgences un patient de 45 ans, pesant 100 kg, brûlé au troisième degré sur tout le bras droit. Les besoins hydriques sont estimés par la formule de Parkland à $4 \times \% \text{ de la SC brûlée} \times \text{kg PC} = \text{ml de perfusion}$.

Q: Quelle quantité de liquide doit être substituée chez ce patient au cours des 24 premières heures ? (SC=surface corporelle, PC=poids corporel)

- a. 1800 ml/24h
- b. 3600 ml/24h**
- c. 7200 ml/24h
- d. 14400 ml/24h

40 Q: Qu'est-ce qui caractérise la phase lutéale du cycle menstruel ?

- a. Augmentation de la progestérone**
- b. Augmentation de la testostérone et de la progestérone
- c. Chute de la température corporelle centrale
- d. Augmentation de la FSH
- e. Sécrétion biphasique de la prolactine

41 Une patiente âgée n'est pas en mesure d'effectuer une abduction active de l'épaule à partir de la position anatomique neutre, bien qu'elle puisse maintenir le bras soulevé passivement en position d'abduction à 90°.

Q: Lequel des muscles ci-dessous est le plus susceptible de ne plus être fonctionnel ?

- a. Muscle trapèze
- b. Muscle deltoïde
- c. Muscle supra-épineux**
- d. Muscle infra-épineux
- e. Muscle subscapulaire
- f. Muscle petit rond

42 Vous examinez une patiente de 60 ans une semaine après un AVC avec pour séquelle une hémiparésie gauche. Dans ce contexte, la patiente souffre d'une légère aphasie avec une incapacité marquée à écrire des mots et des textes. Aucune autre diminution des performances cognitives ne peut être mise en évidence.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. agrafie**
- b. Amnésie

- c. Anosognosie
- d. Trouble de l'adaptation
- e. Dysdiadococinésie
- f. Héminégligence
- g. État de stress post-traumatique
- h. Rigidité

43 Après un examen complet d'un nouveau-né, vous notez des œdèmes de la face dorsale des mains et des pieds ainsi qu'un repli cutané de chaque côté du cou (pterygium colli).

Q: Quelle est l'aberration chromosomique la plus probable ?

- a. Trisomie 21
- b. Syndrome de Turner**
- c. Syndrome de Klinefelter
- d. Syndrome XYY

44 Avant une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, on procède à un repérage du niveau lésionnel en comptant les vertèbres par palpation, en insérant une aiguille stérile comme repère dans l'espace intervertébral concerné et en la visualisant au moyen d'un amplificateur de brillance au bloc opératoire.

Q: Quelle vertèbre peut servir de point de départ pour le comptage lors d'interventions sur la colonne cervicale et la colonne thoracique haute en décubitus ventral ?

- a. La 1^{re} vertèbre thoracique
- b. L'apophyse épineuse de la 3^e vertèbre thoracique
- c. L'apophyse épineuse de la 7^e vertèbre cervicale**
- d. La 12^e vertèbre thoracique

45 Un patient de 76 ans vous consulte pour la première fois après avoir déménagé dans votre région. Il souffre de dépression, d'hypertension artérielle et de diabète sucré de type 2. Il est également atteint d'une dermatomycose. Il prend donc les médicaments suivants : amitriptyline 75 mg 1 x 1, énalapril 5 mg 2 x 1, metformine 850 mg 2 x 1 ; la mycose est traitée avec une crème au clotrimazole. Une toux non productive est apparue depuis plusieurs semaines. Le patient demande si cette toux pourrait être la conséquence de sa prise de médicaments.

Q: Quel médicament est le plus susceptible d'être à l'origine de ce symptôme ?

- a. Metformine
- b. Amitriptyline
- c. énalapril
- d. Clotrimazole
- e. Aucun de ces médicaments

46 Q: Quel est le mécanisme pathogénique des maladies atopiques de l'enfant et de l'adolescent ?

- a. Surproduction d'anticorps IgE contre les allergènes naturels
- b. Réponse excessive des lymphocytes T en post-vaccination
- c. Inflammation médiée par les complexes immuns
- d. Augmentation de la sécrétion de somatostatine par les macrophages

47 Q: Contre laquelle des espèces de streptocoques ci-dessous peut-on se faire vacciner ?

- a. Streptocoques A
- b. Streptocoques B
- c. Entérocoques
- d. Pneumocoques
- e. Streptococcus mutans

48 Q: Dans quelle maladie inflammatoire de l'intestin trouve-t-on typiquement des granulomes à cellules géantes ?

- a. Maladie de Crohn
- b. Colite collagène
- c. Colite pseudomembraneuse
- d. Entérocolite à rotavirus

49 Q: Pourquoi la cornée de l'œil est-elle un organe de privilège immunologique ?

- a. Parce qu'elle est transparente
- b. Parce qu'elle est dépourvue de vaisseaux**
- c. Parce qu'elle est bien innervée
- d. Parce qu'elle est nourrie par l'humeur aqueuse

50 Un patient de 65 ans souffrant d'insuffisance cardiaque (NYHA II) se présente aux urgences après s'être vu prescrire par son médecin traitant un nouveau médicament antihypertenseur. La gazométrie veineuse montre les paramètres suivants : pH 7.35, pCO₂ 35 mmHg, HCO₃ 22 mmol/l, lactates 1.7 mmol/l, glucose 6.1 mmol/l, Na 133 mmol/l, K 6.5 mmol/l, Ca 1.20 mmol/l, Cl 115 mmol/l. (normes : pH 7.35-7.45, pCO₂ 37-43 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/l, lactates 0.6-1.7 mmol/l, glucose 4.2-5.6 mmol/l, Na 135-145 mmol/l, K 3.5-4.6 mmol/l, Calcium total 2.15-2.55 mmol/l, Cl 98-110 mmol/l)

Q: Quel symptôme ou quelle association typique de symptômes faut-il rechercher dans l'anamnèse ?

- a. Faiblesse musculaire**
- b. Signe de Trousseau positif
- c. Faiblesse, palpitations/arythmies, constipation
- d. Confusion, nausées, chutes à répétition
- e. Confusion, polyurie, constipation

51 Un homme de 35 ans raconte qu'en regardant la couche nuageuse claire au cours d'un vol longue distance, il a soudainement vu de petites fibrilles grises qui changeaient légèrement de forme et se déplaçaient dans le champ de vision. Il dit également observer ce phénomène dans d'autres situations, en particulier lorsqu'il est fatigué et qu'il regarde une surface claire avec l'œil droit.

Q: La cause la plus probable de cet effet est la suivante :

- a. Augmentation de la pression intra-oculaire (glaucome)
- b. Décollement de la rétine
- c. petits dépôts dans le corps vitré (myodésopsies/corps flottants)**
- d. Inflammation de la conjonctive (conjonctivite)
- e. Inflammation de la choroïde (choriorétinite)

52 Chez un homme de 45 ans, mesurant 175 cm et pesant 70 kg, une hypertension artérielle a été diagnostiquée il y a 2 ans. Depuis, il prend un traitement antihypertenseur à base de ramipril et d'amlodipine. Cependant, l'hypertension est mal contrôlée et des crises hypertensives avec séjours aux

urgences se sont déjà produites à plusieurs reprises. Lors de ces crises, il a signalé l'apparition de céphalées, de sueurs et de palpitations. Aucune autre maladie n'est connue. Après des investigations complètes, le diagnostic d'hypertension secondaire est retenu. Les anomalies suivantes ont été relevées : pression artérielle 150/90 mmHg, hypertrophie ventriculaire gauche à l'échocardiographie, mise en évidence d'une albuminurie, mise en évidence de métabolites des catécholamines dans les urines de 24 heures, présence de plaques athéromateuses de petite taille dans les artères carotides et rénales des deux côtés à l'écho-Doppler.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Hypertension rénale
- b. Phéochromocytome**
- c. Acromégalie
- d. Syndrome de Cushing

53 Une femme de 39 ans est assise dans son lit et respire rapidement (30/min). Elle réagit à l'appel et présente une pression artérielle basse. La femme se plaint d'une douleur thoracique aiguë du côté gauche. La jambe gauche est plâtrée en raison d'une fracture survenue 4 semaines auparavant. Elle déclare ne pas prendre de médicaments, mis à part un contraceptif oral. L'ECG montre un aspect S1Q3 et une tachycardie sinusale avec une fréquence cardiaque de 140/min.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Syndrome d'hyperventilation
- b. Pneumothorax
- c. Infarctus du myocarde
- d. Embolie pulmonaire**

54 Q: En quoi consiste une dissection fonctionnelle du cou (functional neck dissection) ?

- a. Cervicotomie dans le plan médian et exérèse d'une tumeur avec préservation fonctionnelle
- b. Curage ganglionnaire cervical en épargnant les muscles, les gros vaisseaux et les nerfs**
- c. Exérèse des ganglions et muscles du cou

55 On désigne sous le nom de goitre l'ensemble des hypertrophies de la thyroïde. Sur le plan fonctionnel, les goitres peuvent être euthyroïdiens, hyperthyroïdiens ou hypothyroïdiens.

Q: Parmi les manifestations suivantes, laquelle est la plus évocatrice d'un goitre hypothyroïdien ?

- a. Tachycardie
- b. Exophtalmie
- c. Tremblement fin des mains
- d. Prise de poids
- e. Différence systolo-diastolique supérieure à 60 mmHg

56 Une patiente obèse de 65 ans, connue pour une hypertension artérielle et un diabète sucré de type 2, se présente au cabinet de médecine de famille pour un état de malaise général, d'asthénie et une dyspnée d'effort. Elle dit avoir l'estomac noué. L'examen donne les résultats suivants : pression artérielle 130/80 mmHg, fréquence cardiaque 45/min. L'ECG révèle un bloc AV du II° de type Mobitz 2.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Rupture de la paroi du ventricule gauche
- b. Myocardite aiguë
- c. Dissection aortique
- d. Embolie pulmonaire
- e. Infarctus myocardique de la paroi inférieure

57 Un garçon âgé d'un an a atteint un poids corporel de 7 kg. Depuis l'âge de deux mois, il souffre d'infections respiratoires récidivantes. L'enfant suit un traitement sécrétoytique et fait des inhalations de sérum physiologique depuis plusieurs mois. De plus, depuis quelque temps, il présente également des troubles digestifs avec des selles volumineuses et très malodorantes. L'abdomen est nettement distend.

Q: De quelle maladie l'anamnèse est-elle caractéristique ?

- a. Bronchite chronique
- b. Malformation cardiaque congénitale
- c. Mucoviscidose
- d. Syndrome d'immunodéficience congénitale
- e. Maladie cœliaque

58 Un homme de 75 ans signale un essoufflement progressif depuis 2 ans. Au cours des 6 derniers mois, une toux sèche s'est ajoutée occasionnellement. Pas de douleur thoracique, pas de palpitation cardiaque ni de gonflement des jambes. Le patient ne prend aucun médicament. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis 58 ans et ne boit pas d'alcool. L'examen clinique est le suivant : température 37.0 °C, pouls 95/min, fréquence respiratoire 20/min et pression artérielle 123/76 mmHg. La saturation à l'oxymètre de pouls est de 89 % à l'air ambiant. Le patient présente une légère dyspnée à la parole. L'auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants fins et secs aux deux bases. L'auscultation cardiaque montre des bruits du cœur réguliers, sans souffle. On note un hippocratisme digital ainsi qu'une turgescence jugulaire. Tous les résultats des examens biologiques sont dans les normes. La radiographie du thorax montre des opacités réticulaires éparses des deux bases pulmonaires. Il n'y a pas de lymphadénopathie hilaire.

Q: Quelle est la prochaine étape diagnostique appropriée ?

- a. Scanner thoracique à haute résolution
- b. Biopsie pulmonaire
- c. PET-scan thoracique
- d. Dosage des anticorps anti-membrane basale glomérulaire

59 Chez un enfant de 4 ans, on note, sur un total de trois jours et en plusieurs poussées, l'apparition de macules prédominant au niveau du tronc, du visage et du cuir chevelu. Celles-ci se transforment rapidement en petites vésicules remplies d'eau et entourées d'une bordure rouge avant de dessécher au bout de quelques jours pour former une croûte. Il y a de fortes démangeaisons et une fièvre légère.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Rougeole
- b. Rubéole
- c. Varicelle
- d. xanthème subit

60 Un homme de 42 ans vous consulte en bon état général, accompagné de sa femme. Il a été licencié pour cause d'ébriété au travail. Son épouse signale une

consommation quotidienne d'alcool commençant dès l'après-midi (env. 2 litres de bière). Plusieurs tentatives de limitation de la consommation d'alcool ont échoué. Il exprime une forte motivation à l'abstinence et au traitement de son alcoolisme.

Q: Quelle est l'approche thérapeutique de premier choix dans ce cas ?

- a. Sevrage ambulatoire
- b. Training autogène
- c. Gestalt-thérapie
- d. Thérapie de couple
- e. Relaxation musculaire progressive
- f. Psychothérapie en groupe
- g. Sevrage hospitalier
- h. Entraînement aux activités de la vie quotidienne
- i. Thérapie comportementale

61 Un prématuré né à 26 semaines de gestation développe un syndrome de détresse respiratoire néonatale (IRDS) atteignant le stade 4.

Q: Quelle intervention thérapeutique peut améliorer de manière décisive l'oxygénation du sang ?

- a. Ventilation mécanique avec des pressions de ventilation très élevées
- b. Administration d'un agent tensioactif
- c. Drainage pleural pour éviter un pneumothorax
- d. Administration d'oxygène à haute concentration

62 Plusieurs essais médicamenteux ont démontré des effets positifs sur la fonction cognitive en cas de démence de type Alzheimer.

Q: Comment caractériser ces médicaments d'un point de vue pharmacologique ?

- a. Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase
- b. Bêtabloquants
- c. Parasympathomimétiques
- d. Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire
- e. Inhibiteurs de la Na/K-ATPase

63 Un patient développe des érysipèles récidivants au niveau de la jambe droite, traités par antibiothérapie orale. Par la suite, un gonflement en partie irréversible de la jambe et du dos du pied apparaît de manière progressive.

Q: Quelle est la maladie sous-jacente la plus probable ?

- a. Phlébothrombose non diagnostiquée
- b. Lymphoœdème secondaire**
- c. Œdème de carence en protéines
- d. Persistance de l'agent pathogène
- e. Œdème hydrostatique veineux

64 Après un traitement médicamenteux antipsychotique, un patient de 17 ans développe des spasmes de la langue et du pharynx.

Q: Quelle est la médication la plus appropriée dans ce cas ?

- a. Halopéridol
- b. Biperidène**
- c. Maprotiline
- d. Zuclopenthixol
- e. Fexofénadine

65 Q: Avec quelle substance peut-on antagoniser l'effet de la phénprocoumone ?

- a. Vitamine B12
- b. rt-PA
- c. Streptokinase
- d. Vitamine K**
- e. Sulfate de protamine

66 Vous traitez un patient avec de l'héparine non fractionnée (HNF). Le temps partiel de thromboplastine (PTT) a augmenté à >200 s.

Q: Quelle est la substance la plus appropriée pour traiter le patient afin de ramener son PTT à la normale ?

- a. Vitamine B12
- b. rt-PA
- c. Streptokinase

- d. Vitamine K
- e. Protamine

67 Chez une jeune fille de 14 ans, vous constatez les symptômes suivants : cachexie, hypothermie, œdèmes, troubles de la perception corporelle et aménorrhée.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Anorexie mentale
- b. Syndrome hémolytique et urémique
- c. Grossesse
- d. Diabète insipide
- e. Schizophrénie

68

Un homme de 67 ans est amené aux urgences pour des douleurs thoraciques. Vous avez exclu un syndrome coronarien de type STEMI avec un ECG 12D. Sur la radiographie thoracique de face, vous constatez un élargissement du médiastin. Il n'y a pas de signes cliniques ni de valeurs biologiques en faveur d'une infection pulmonaire. Interrogé, le patient déclare avoir beaucoup fumé jusqu'à il y a deux ans.

Q: Quel est le prochain examen indiqué ?

- a. Explorations fonctionnelles respiratoires
- b. Angio-scanner thoracique
- c. Recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants dans le crachat
- d. Détermination de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) dans le sang

69 On vous appelle au chevet d'une patiente hospitalisée, somnolente en raison d'une décompensation de son diabète (actuellement plus de 30 mmol/l, norme : 3.7-5.6 mmol/l). La patiente est entièrement alimentée par voie parentérale, elle hyperventile fortement. L'hyperventilation est due à une acidose métabolique avec un pH artériel de 7.2 (norme : 7.35-7.45).

Q: Par quelle mesure faut-il commencer le traitement ?

- a. 2 l d'oxygène au masque
- b. Arrêt de la nutrition parentérale
- c. Insuline et solution d'électrolytes en i.v.
- d. Perfusion de bicarbonates de sodium

70 Un footballeur de 28 ans a été victime d'un traumatisme abdominal fermé lors d'un entraînement. À l'examen initial, il est stable sur le plan hémodynamique. L'échographie abdominale réalisée est sans particularité. Cinq jours plus tard, une chute de l'hémoglobine et de la pression artérielle se produit.

Q: Quelle est la cause la plus probable de cette situation ?

- a. Rupture diaphragmatique non diagnostiquée au départ
- b. Rupture de la rate en deux temps**
- c. Hémorragie intrahépatique
- d. Contusion pancréatique
- e. Hémorragie digestive haute

71 **Q: Pour quel carcinome une infection virale représente-t-elle un facteur de risqué ?**

- a. Carcinome du col utérin**
- b. Carcinome de l'endomètre
- c. Carcinome ovarien
- d. Carcinome mammaire

72 Une femme de 36 ans, accouchant pour la deuxième fois (status après césarienne) et avec une présentation du siège, vous consulte à la 36e semaine de grossesse pour une rupture prématurée de la poche des eaux sans mise en travail. Le status obstétrical à l'admission donne les résultats suivants : col ouvert à 2 cm, perte de liquide amniotique teinté de vert, siège engagé dans le détroit supérieur. Échographie : dos à gauche, placenta antérieur, poids de naissance estimé à 3'000 g. Le monitoring fœtal met en évidence des décélérations tardives en présence de contractions utérines de faible intensité.

Q: Quelle est la procédure obstétricale indiquée ?

- a. Césarienne après réalisation d'une maturation pulmonaire fœtale
- b. Césarienne immédiate**
- c. Version par manœuvre externe sous tocolyse intraveineuse, puis attendre l'accouchement spontané
- d. Accouchement spontané après réalisation d'une maturation pulmonaire fœtale

- e. Déclenchement artificiel du travail avec du gel de prostaglandines et attendre l'accouchement spontané

73 Q: Pour quelle maladie utilise-t-on des substances ayant un effet agoniste sur les récepteurs alpha-1 ?

- a. Hypotension
- b. Hyperthyroïdie
- c. Hyperaldostéronisme primaire
- d. Phéochromocytome

74 Q: Quelle pathologie de l'articulation du genou prédispose le plus à une luxation de la rotule ?

- a. Genu valgum
- b. Gonagre
- c. Atrophie musculaire neurogène
- d. Rupture du ligament croisé antérieur

75 Une patiente de 54 ans est admise aux urgences pour une détresse respiratoire aiguë. L'examen révèle un gonflement des lèvres, de la langue et du larynx. La patiente doit être prise en charge de toute urgence.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Crise d'asthme aiguë
- b. Angioœdème
- c. Décompensation cardiaque aiguë avec turgescence jugulaire
- d. Mononucléose infectieuse

76 Q: Quelle est la cause la plus fréquente de pancréatite chronique récidivante ?

- a. Abus d'alcool
- b. Calculs biliaires
- c. Mucoviscidose

- d. Complications après une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE ou ERCP en anglaise)
- e. Hépatite C

77 On vous appelle en salle d'accouchement trois heures après la naissance d'un nouveau-né. Vous constatez une cyanose marquée avec une saturation transcutanée en oxygène de 78 %.

Q: Quelle est la méthode de choix pour faire une première différenciation entre une malformation cardiaque et une cause pulmonaire ?

- a. Brève administration d'oxygène pur
- b. Radiographie du thorax
- c. Gazométrie sanguine
- d. Échocardiographie

78 La mise en place d'un drainage de Bülow pour pneumothorax peut provoquer une lésion vasculaire responsable d'une complication hémorragique.

Q: Quel est le vaisseau le plus susceptible d'être endommagé dans cette situation ?

- a. Artère subclavière
- b. Veine intercostale
- c. Veine brachiocéphalique
- d. Veine hémiazygos

79 Lors d'un examen physique, vous posez le diagnostic de pneumothorax.

Q: Quelle est la lésion pulmonaire préalable la plus susceptible d'en être la cause ?

- a. Dystélectasie pulmonaire
- b. Bulle d'emphysème
- c. Fibrose pulmonaire
- d. Abscès du poumon
- e. Pneumonie

80 Un homme de 30 ans, fortement alcoolisé, est amené aux urgences.

Q: À quelle altération de son équilibre hydrique peut-on s'attendre ?

- a. Le volume sanguin a augmenté parce que l'alcool a été ingéré sous une forme très diluée (bière).
- b. Le volume sanguin a augmenté parce que l'élimination d'urine par les reins – endommagés par l'alcool qui est néphrotoxique – est altérée.
- c. Le volume sanguin a diminué parce que la perméabilité de la capsule de Bowman a augmenté.
- d. Le volume sanguin a diminué parce que l'alcool inhibe la sécrétion hypophysaire de l'hormone antidiurétique.

81 Un patient ayant subi un infarctus du myocarde il y a trois ans souffre d'une insuffisance cardiaque gauche chronique progressive.

Q: Lequel des médicaments ci-dessous N'est PAS indiqué pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique ?

- a. Dobutamine
- b. Digoxine
- c. Carvédilol
- d. Furosémide
- e. Ramipril

82

Chez un patient aveugle, on trouve un examen normal des réflexes pupillaires à la lumière.

Q: Où le trouble visuel doit-il être localisé ?

- a. Dans le cortex visuel
- b. Dans le tractus optique
- c. Dans le chiasma optique
- d. Dans le nerf optique
- e. Dans la rétine

83

Un patient de 19 ans présente des plaques rouges violacées douloureuses et légèrement surélevées sur les faces d'extension des deux jambes, associées à un état subfébrile. Deux jours plus tard, un gonflement douloureux de la cheville droite apparaît. Il n'y a pas d'autres symptômes, et le reste de l'anamnèse est sans particularité. Toutefois, le patient a été informé que la radiographie thoracique réalisée à l'occasion d'un examen d'embauche il y a quelques

semaines avait révélé une anomalie hilaire bilatérale. Les examens complémentaires recommandés n'ont pas été effectués jusqu'à présent.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Syndrome de Heerfordt
- b. **Syndrome de Löfgren**
- c. Syndrome de Reiter
- d. Syndrome de Sjögren

84 Une fillette de 8 ans présente pour la troisième fois une méningite à pneumocoques d'origine indéterminée. À l'anamnèse, les parents confirment l'absence d'otite moyenne, d'opération du nez ou de traumatisme crânien. L'examen ORL est sans particularité. L'ouïe et l'odorat sont intacts.

Q: Quelle est la cause la plus probable ?

- a. Amygdalite chronique
- b. Kyste du sinus maxillaire
- c. **Fistule durale congénitale**
- d. Otite Moyenne chronique

85 Un ganglion lymphatique situé sur le côté du muscle sterno-cléido-mastoïdien est enlevé pour des raisons diagnostiques chez une jeune fille de 14 ans. En postopératoire, la patiente remarque une faiblesse du bras en portant son sac. L'épaule droite est nettement plus basse. L'électromyographie montre une parésie de la partie supérieure du muscle trapèze.

Q: La lésion de quel nerf est la plus susceptible d'être responsable de cette situation ?

- a. Nerf grand occipital
- b. **Nerf accessoire**
- c. Nerf grand auriculaire
- d. Nerf du plexus cervical
- e. Nerf du plexus brachial

86 Un patient a du mal à déplacer sa jambe vers l'arrière, à la tourner vers l'intérieur ou à redresser complètement son dos.

Q: Quel muscle raccourci l'empêche d'effectuer ce mouvement ?

- a. Muscle grand glutéal
- b. Muscle vaste médial
- c. Muscle ilio-psoas
- d. Muscle rhomboïde

87 Q: Quel médicament permet d'antagoniser tous les effets de la morphine ?

- a. Buprénorphine
- b. Nalorphine
- c. Naloxone
- d. Pentazocine

88 Q: Qu'est-ce qui détermine le degré d'activité histopathologique d'une gastrite bactérienne ?

- a. Le degré de formation de follicules lymphoïdes dans la muqueuse
- b. L'étendue de l'hyperplasie foveolaire
- c. La présence d'une métaplasie intestinale
- d. L'infiltration par des granulocytes neutrophiles

89 Q: Quel examen de laboratoire est important pour déterminer le stade et l'évolution d'une infection par le VIH ?

- a. Mesure des paramètres inflammatoires sériques
- b. Mise en évidence des gammaglobulines à l'électrophorèse des protéines sériques
- c. Numération des lymphocytes CD4 positifs par cytométrie de flux
- d. Test de transformation lymphoblastique par des antigènes spécifiques

90 Un nouveau-né présente une cyanose après un accouchement sans complications. L'échocardiographie révèle une transposition des gros vaisseaux.
Q: Quelle est la mesure immédiate à prendre ?

- a. Administration de prostaglandine E
- b. Administration d'ibuprofène

- c. Transplantation cardiaque immédiate
- d. Cathétérisme cardiaque

91 Un patient de 50 ans se présente pour un scanner thoracique après qu'une opacité anormale a été notée sur la radiographie du thorax. L'épouse qui accompagne le patient prend congé durant l'examen pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. Le scanner révèle un nodule pulmonaire solitaire à contours flous et spiculés, un épanchement ipsilatéral et des prolongements linéaires vers la plèvre.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Aspergillome
- b. Cicatrices résiduelles (TBC)
- c. **Carcinome pulmonaire**
- d. Pneumonie fongique
- e. Abscess du poumon

92 Chez une patiente atteinte d'un lupus érythémateux disséminé et traitée par corticostéroïdes, on réalise une radiographie du thorax en position debout en raison de troubles respiratoires modérés et de douleurs abdominales. L'examen met en évidence la présence d'air libre sous le diaphragme.

Q: Quelle est la cause la plus probable ?

- a. Pneumothorax
- b. **Perforation d'ulcère gastrique**
- c. Hernie hiatale
- d. Gangrène gazeuse
- e. Colite ulcéreuse

93 **Q: Laquelle des observations suivantes permet de reconnaître avec certitude un orifice d'entrée créé par un projectile d'arme à feu ?**

- a. Les bords de la plaie peuvent être rapprochés complètement.
- b. **Les bords de la plaie présentent une collerette érosive.**
- c. La plaie contient des fibres du vêtement traversé par le projectile.
- d. Le tissu traversé par la balle est de couleur rouge clair en raison du CO-Hb.

94 Une patiente se rend chez sa gynécologue et lui annonce qu'elle a été violée quelques heures auparavant.

Q: Laquelle des mesures suivantes devrait-elle, en accord avec la victime, mettre en œuvre de manière particulièrement urgente ?

- a. Test d'Ouchterlony et prélèvement de frottis vaginaux
- b. Documentation des blessures et prélèvement de frottis vaginaux**
- c. Documentation des blessures et prophylaxie post-exposition
- d. Dépôt de plainte à la police et information sur les procédures judiciaires

95 Une jeune femme se présente à votre cabinet avec des douleurs pelviennes lancinantes, irradiant vers l'intérieur de la cuisse droite.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Colique néphrétique
- b. Carcinome ovarien
- c. Appendicite
- d. Annexite**
- e. Syphilis

96 Une femme de 69 ans se présente chez vous aux urgences avec un abdomen aigu. La patiente est connue pour une maladie cardiaque avec troubles du rythme cardiaque. La patiente n'a jamais subi d'intervention chirurgicale. L'examen physique donne les résultats suivants : abdomen distendu et météorisé, absence de péristaltisme, arythmie, pas de fièvre. Au laboratoire, l'Hémoglobine est à 12 g/dl (N : 12 – 16), les leucocytes à 25'000/ μ l (N : 4.5 – 11.5), les thrombocytes à 150'000/ μ l (N : 150'000 – 450'000), le lactate est élevé, l'amylase et la lipase sériques sont normales.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Iléus sur bride
- b. Volvulus du sigmoïde
- c. Infarctus aigu de la paroi inférieure du myocarde
- d. Infarctus mésentérique aigu**
- e. Pancréatite aiguë

97 Une femme de 42 ans consulte son médecin en lui signalant des douleurs au sein gauche. Le médecin trouve une rougeur étendue sur la paroi thoracique

gauche avec des limites nettes. À la palpation, il constate un parenchyme glandulaire densifié des deux côtés, sans nodule repérable.

Q: Quelle mesure diagnostique est la plus adéquate ?

- a. Dosage de la protéine C-réactive (CRP) et biopsie cutanée
- b. Scanner (TDM/CT) thoracique
- c. Tomographie par émission de positons (TEP/PET)
- d. Analyse génétique selon BRCA1 et BRCA2 (Breast Cancer Gene)

98 Une femme de 55 ans se présente aux urgences avec une colique néphrétique et une hématurie. L'échographie révèle la présence de multiples calculs rénaux. Le calcium sérique est de 2.7 mmol/l (norme : 2.15-2.65 mmol/l), la parathormone de 127 ng/l (norme : 11-65 ng/l). La fonction rénale et l'albumine sérique sont dans la norme.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Hyperparathyroïdie primaire
- b. Hyperparathyroïdie secondaire
- c. Hyperparathyroïdie tertiaire
- d. Hypoparathyroïdie
- e. Pseudo-hypoparathyroïdie
- a. Je ne sais pas la réponse

99 Q: Pour lequel des carcinomes suivants faut-il penser à une NEM 2 (néoplasie endocrinienne multiple) ?

- a. Carcinome médullaire de la thyroïde
- b. Carcinome bronchique à petites cellules
- c. Carcinome ovarien
- d. Carcinome mammaire

100 Un homme de 40 ans subit une thoracotomie postéro-latérale gauche avec résection partielle du poumon. En peropératoire, un drain thoracique est placé dans la cavité pleurale gauche afin de permettre l'évacuation du sang résiduel de celle-ci. Après une évolution postopératoire sans complications, le patient est extubé et transféré de l'unité de soins intensifs à l'unité périphérique. Deux jours après l'opération, vous constatez que le liquide de drainage montre un aspect laiteux et non sanguinolent avec mise en évidence des taux de cholestérol et de triglycérides supra-systémiques. L'état clinique du patient est stable.

Q: Qu'est-ce qui explique ce tableau clinique ?

- a. Lésion du canal thoracique
- b. Formation d'une fistule œsophago-trachéale
- c. Sérothorax
- d. Augmentation aiguë du cholestérol et des triglycérides dans le sang

101 Q: Quel est le facteur pronostique le plus important du mélanome malin de stade I et II ?

- a. Âge
- b. Épaisseur de la tumeur
- c. Localisation
- d. Sexe

102 Un patient est amené aux urgences par l'hélicoptère de sauvetage. Il ne réagit pas à la parole, est tachycarde, hypotendu et présente une large plaie à la cuisse qui semble un peu âgée et dégage une odeur putride. Vous percevez un crépitement à la palpation.

Q: Quel agent pathogène est le plus susceptible de provoquer ce tableau clinique ?

- a. *Clostridium perfringens*
- b. *Pseudomonas aeruginosa*
- c. *Corynebacterium diphtheriae*
- d. *Staphylococcus aureus*
- e. *Mycoplasma hominis*

103 Un patient de 81 ans, qui se plaint de douleurs dorsales, d'une faiblesse générale et d'une perte de poids involontaire de 15 kg, signale une urine mousseuse. Le CT-scan à faible dose du corps entier montre de multiples foyers d'ostéolyse.

Q: Quelles sont les cellules très probablement dégénérées chez ce patient ?

- a. Basophiles
- b. Éosinophiles
- c. Monocytes
- d. Neutrophiles
- e. Plasmocytes

104 Un patient séropositif de 33 ans vous consulte. Jusqu'à présent, il n'a pas reçu de traitement antirétroviral et il n'a aucune maladie définissant le SIDA dans ses antécédents. Vous trouvez des plaques blanchâtres sur son palais et la face interne de ses joues, adhérent à l'épithélium et ne s'effaçant pas au frottement.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. **Muguet buccal**
- b. Leucoplasie
- c. Mauvaise hygiène buccale
- d. Diphtérie
- e. Carcinome épidermoïde de la cavité buccale

105 L'IRM d'une patiente connue pour une maladie de Crohn révèle une inflammation touchant une grande partie de l'iléon.

Q: Quelle est la vitamine dont l'absorption est la plus perturbée chez cette patiente ?

- a. Vitamine B1
- b. Vitamine B2
- c. Vitamine B3
- d. **Vitamine B12**

106 Une patiente de 72 ans souffrant de douleurs dorsales persistantes a reçu un traitement symptomatique qui est resté sans succès jusqu'à présent. La radiographie de la colonne vertébrale qui vient d'être réalisée montre des signes de destructions ostéolytiques, et l'électrophorèse du sérum montre une bande discrète supplémentaire.

Q: Quelle est la prochaine étape diagnostique ?

- a. **Identification des paraprotéines dans le sérum par immunofixation**
- b. Scintigraphie osseuse du corps entier
- c. Biopsie à l'emporte-pièce de l'une des vertèbres concernées
- d. Dosage de marqueurs tumoraux
- e. Ostéodensitométrie (mesure de la densité minérale osseuse)

107 **Q: Quelle est la méthode la plus fiable pour le diagnostic prénatal de la maladie hémolytique du nouveau-né ?**

- a. Mesure du taux fœtal de bilirubine
- b. **Mesure du titre d'anticorps anti-Rhésus maternel**
- c. Mesure du taux maternel de bilirubine
- d. Dosage de l'hémoglobine fœtale

108 Q: Laquelle des couches suivantes de l'endomètre est à l'origine de la régénération post-menstruelle ?

- a. Couche compacte
- b. **Couche basale**
- c. Couche spongieuse
- d. Couche fonctionnelle

109 Une jeune femme de 24 ans souffre depuis deux jours d'une miction très douloureuse, associée à une pollakiurie, et se présente donc chez son médecin de famille. Elle n'a pas de fièvre. La culture d'urine montre la présence de bacilles à Gram négatif.

Q: De quel agent pathogène s'agit-il le plus probablement ?

- a. Candida albicans
- b. Pseudomonas aeruginosa
- c. Enterococcus faecalis
- d. **Escherichia coli**
- e. Haemophilus influenzae
- f. Neisseria gonorrhoeae

110 Un enseignant de 64 ans est soudainement atteint de troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que d'une hémiparésie gauche transitoire.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Démence d'Alzheimer
- b. Dépression
- c. **Démence vasculaire**
- d. Syndrome de Parkinson
- e. Démence frontotemporale

111 Les tumeurs des glandes salivaires peuvent se développer dans les trois grandes glandes salivaires ainsi que dans les petites glandes salivaires principalement disséminées dans la cavité buccale.

Q: Quelle est la tumeur des glandes salivaires la plus fréquente ?

- a. Cystadénolymphome
- b. Tumeur de Küttner
- c. Adénome pléomorphe des glandes salivaires
- d. Carcinome des glandes salivaires

112 Q: Quelle est la signification d'une valeur prédictive positive (vpp) de 0.8 lors de l'évaluation du résultat d'un test dans le cadre d'un programme organisé de dépistage ?

- a. 80 % de tous les patients inclus dans le programme de dépistage sont en bonne santé.
- b. La probabilité que la personne dont le test est positif soit réellement malade est de 80 %.
- c. 80 % des malades sont testés positifs par le programme de dépistage.
- d. 80 % de la population cible du programme de dépistage ont participé à l'examen.
- e. Le risque relatif de développer la maladie est de 80 %.

113 Un homme de 27 ans se présente en raison d'un mal de gorge depuis cinq jours. Il y a trois jours, on lui a prescrit un antibiotique, probablement de la pénicilline. Les douleurs auraient toutefois continué à augmenter. L'ingestion d'aliments solides est impossible depuis hier, il dit n'avoir bu que quelques gorgées d'eau. L'ouverture de la bouche est à peine possible et on constate une tuméfaction marquée du palais mou du côté gauche ainsi qu'une haleine fétide.

Q: Quelle est la cause la plus probable de ce tableau clinique ?

- a. Sinusite maxillaire aiguë gauche
- b. Hémorragie dans le muscle masséter
- c. Abscess péri-amygdalien
- d. Candidose oro-pharyngée

114 Un homme de 29 ans signale une gêne marquée de la respiration nasale, s'accroissant pendant le sommeil et accompagnée d'une rhinorrhée aqueuse et

de crises d'éternuement. Il n'a pas d'autre maladie et ne prend pas de médicaments.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Rhinite sèche
- b. Rhinite allergique
- c. Rhinite vasomotrice
- d. Rhinite purulente aiguë

115 Après un remplacement valvulaire aortique, un patient de 68 ans présente soudainement une fibrillation ventriculaire sur le moniteur de surveillance.

Q: Quelle est la première mesure à prendre ?

- a. Défibrillation
- b. Administration de lidocaïne
- c. Administration de propafénone
- d. Administration de suprarénine

116 Q: Laquelle des cardiopathies congénitales suivantes entraîne un shunt primaire gauche-droit ?

- a. Coarctation de l'aorte
- b. Sténose pulmonaire
- c. Transposition des gros vaisseaux
- d. Communication interventriculaire

117 Q: Quels sont les premiers symptômes pouvant être provoqués par une tumeur de l'angle ponto-cérébelleux ?

- a. Amputation du champ visuel et céphalées
- b. Trouble de l'audition et acouphènes
- c. Hémiparésie et ptosis
- d. Névralgie du trijumeau et dysphagie

118 Q: Quel groupe de patients est le plus susceptible d'avoir besoin d'une prophylaxie de l'endocardite avant une intervention de chirurgie buccale ?

- a. Patients présentant une communication interauriculaire de type ostium secundum
- b. Patients présentant une sténose valvulaire aortique de degré élevé
- c. Patients ayant subi un remplacement valvulaire mécanique
- d. Patients présentant une insuffisance valvulaire mitrale modérée

119 Vous arrivez en salle de réveil et trouvez une patiente de 28 ans, tremblante mais stable sur le plan cardiopulmonaire, qui vient de subir une intervention sur la colonne vertébrale. Vous diagnostiquez un frisson postopératoire (shivering).

Q: Quelle substance est la plus susceptible d'être administrée à la patiente ?

- a. Aténolol
- b. Clonidine
- c. Midazolam
- d. Pirétramide

120 Un patient de 80 ans souffre de fibrillation atriale permanente depuis longtemps, sans valvulopathie. En raison de son âge, d'une alimentation peu équilibrée et de ses nombreuses pathologies au plan neurocognitif, le score CHA2DS2-VASc est de 5.

Q: Quel est le traitement anticoagulant le plus approprié ?

- a. AAS
- b. Apixaban
- c. Clopidogrel

121 Un jeune apprenti de 22 ans se réveille régulièrement vers quatre heures du matin avec des douleurs dans la région lombaire. Il se sent raide dans le dos et se lève. Après environ une demi-heure de mouvement, la douleur s'atténue. Son tendon d'Achille droit est épaissi et douloureux.

Q: Au vu de cet ensemble symptomatique, quelle est la pathologie la plus probable ?

- a. Ostéoporose
- b. Spondylodiscite
- c. Tuberculose vertébrale
- d. Spondylarthrite ankylosante

- e. Spondylose
- f. Plasmocytome

122 Q: Quelle maladie est la plus fréquemment secondaire à une polykystose rénale autosomique dominante ?

- a. Anévrisme de l'aorte
- b. Subluxation du cristallin
- c. Exanthème
- d. Hyperglycémie
- e. Hypertension artérielle

123 L'acide acétylsalicylique (AAS) peut, dans de rares cas, provoquer une détresse respiratoire aiguë.

Q: Quel est le mécanisme sous-jacent ?

- a. Une excitation des récepteurs muscariniques au niveau des bronches
- b. Une production excessive de leucotriènes
- c. Un blocage des récepteurs bêta-2 bronchiques
- d. Une production excessive de prostacycline I2 déclenchant un bronchospasme

124 Un pneumothorax sous tension est diagnostiqué chez un patient de 63 ans. L'aire de matité cardiaque et le choc apexien sont déplacés vers la droite.

Q: À quel résultat peut-on s'attendre ?

- a. Abolition du murmure vésiculaire du champ pulmonaire droit
- b. Bradycardie
- c. Diminution de la pression veineuse centrale
- d. Déviation du médiastin vers la droite

125 Une étude épidémiologique cherche à déterminer si les personnes exposées de manière chronique à des niveaux de bruits intenses présentent un risque accru d'infarctus du myocarde. Pour ce faire, tous les patients victimes d'un infarctus du myocarde sont interrogés par questionnaire sur leur exposition au bruit au cours des dernières années. Les patients en bonne santé cardiaque et souffrant de pathologies chirurgicales sont également interrogés sur leur exposition au bruit.

Q: Quel outil statistique permet de quantifier le résultat de cette étude, à savoir le lien entre l'exposition au bruit et l'infarctus du myocarde ?

- a. Incidence
- b. Prévalence
- c. Odds ratio
- d. Sensibilité
- e. Spécificité

126 Vous suivez une femme enceinte de 26 ans souffrant de diabète sucré de type 1. Elle est à 24 semaines de grossesse et n'a pas eu de problèmes de contrôle métabolique jusqu'à présent.

Q: À quel changement important doit-elle s'attendre dans le traitement de son diabète pour le reste de sa grossesse ?

- a. Augmentation des besoins en glucides
- b. Augmentation des besoins caloriques
- c. Augmentation des besoins en protéines
- d. Augmentation des besoins en insuline

127 La coupe histologique d'un rein montre de nombreux tubules remplis de cylindres (casts). La coloration à l'hémalum-éosine est positive pour la myoglobine.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Insuffisance rénale aiguë après écrasement (crush syndrome)
- b. Insuffisance rénale aiguë due à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
- c. Insuffisance rénale chronique

128 Un homme de 53 ans vous consulte à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé divers : acouphènes, vertiges soudains, troubles gastro-intestinaux. Jusqu'à présent, aucune raison somatique n'a pu être trouvée pour expliquer ces troubles. L'homme se plaint également de problèmes de concentration, de fatigue et d'une baisse générale de ses performances au travail. De plus, sa mère est tombée gravement malade et a maintenant besoin de beaucoup de soins de sa part. Il a l'impression de ne plus être à la hauteur de toutes ces exigences.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Trouble de l'adaptation
- b. **Burn-out**
- c. Trouble dissociatif
- d. Hypercalcémie
- e. Hypokaliémie
- f. Maladie de Ménière
- g. État de stress post-traumatique

129 Un père et un fils ont la même maladie génétique.

Q: Quelle est la cause possible si la mère n'est pas atteinte de la maladie et que la possibilité d'être porteuse d'un gène de prédisposition a été exclue ?

- a. Une maladie due à une mutation de l'ADN mitochondrial
- b. **Une mutation autosomique dominante**
- c. Une mutation dominante liée au chromosome X
- d. Une mutation récessive liée au chromosome X

130 Un patient se présente à votre cabinet avec une toux persistant depuis longtemps, une dyspnée, une douleur thoracique et un état d'abattement. L'anamnèse révèle que dans les années 80, le patient a été exposé à l'amiante pendant plusieurs années, dans le cadre de son activité professionnelle. Le patient ne fume pas et, selon ses propres dires, il est en bonne santé habituelle.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Bronchite chronique
- b. **Mésothéliome pleural**
- c. Pleurésie sèche
- d. Sarcoïdose
- e. Silicose

131 **Q: Laquelle des tumeurs ovariennes ci-dessous est la plus susceptible d'inclure des ébauches dentaires ?**

- a. Arrénoblastome
- b. Tumeur de Brenner
- c. **Kyste dermoïde**
- d. Cystadénome séreux

- e. Tumeur à cellules thécales

132 Chez une patiente de 36 ans souffrant de troubles menstruels, on réalise une hystéroscopie opératoire pour enlever une tumeur sous-muqueuse bénigne.

Q: Quelle est l'origine cellulaire la plus probable de cette pathologie ?

- a. Chondrocytes
- b. Cellules endothéliales
- c. Fibrocytes
- d. Cellules musculaires lisses
- e. Ostéoblastes

133 Q: Qu'est-ce qui permet l'application de la règle dite « de la ligne du bord du chapeau » dans l'appréciation des traumatismes crâniens contondants ?

- a. Conclusions sur la nature de l'objet contondant
- b. Détermination de l'ordre chronologique en cas de violences multiples
- c. Estimation de l'âge des lésions
- d. Différenciation entre chute et agression physique

134 Chez un patient âgé de 84 ans, sujet aux pleurs et souffrant de pertes de mémoire, le médecin de famille qui lui rend régulièrement visite est confronté au problème de devoir distinguer une dépression d'une évolution démentielle.

Q: Laquelle des observations suivantes devrait particulièrement lui faire penser à un syndrome démentiel ?

- a. Le patient est conscient de la perte de ses capacités cognitives.
- b. Consultation médicale relativement rapide en raison des changements cognitifs
- c. Son estime de soi est affectée.
- d. Un début insidieux et plutôt discret des changements cognitifs
- e. Peur de l'échec

135 Chez un toxicomane i.v., le bilan sérologique des hépatites montre les résultats suivants : antigènes HBs et HBe positifs, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc tous négatifs (à la fois IgM et IgG).

Q: Comment interpréter au mieux ces résultats ?

- a. Hépatite B aiguë (phase tardive)
- b. Porteur de l'antigène HBs, infectiosité généralement faible
- c. **Porteur du virus de l'hépatite B, infectiosité élevée**
- d. Status après hépatite B sans formation d'anti-HBs ou low-level carrier
- e. tatus après hépatite B, immunité

136 Après une chute, une jeune femme se plaint d'une douleur au niveau de la cheville. L'anamnèse révèle comme mécanisme accidentel une chute par accrochage de la pointe du pied, ce qui a entraîné une flexion plantaire maximale et une supination.

Q: Quel est le ligament le plus susceptible d'être déchiré ?

- a. Partie tibio-talaire antérieure du ligament deltoïde
- b. Partie tibio-talaire postérieure du ligament deltoïde
- c. Partie tibio-naviculaire du ligament deltoïde
- d. **Ligament talo-fibulaire antérieur**
- e. Ligament talo-fibulaire postérieur

137 Une patiente de 26 ans se présente aux urgences avec une dyspnée progressive ayant commencé peu après le début de sa deuxième grossesse. Sa première grossesse, 18 mois auparavant, a provoqué des symptômes similaires et s'est terminée par un avortement spontané. À l'admission aux urgences, elle est à 14 semaines de grossesse. Elle n'a pas de fièvre, son pouls est à 120/min et sa pression artérielle à 120/70 mmHg. L'auscultation cardiaque révèle un éclat du premier bruit et un souffle diastolique, perçus à l'apex cardiaque.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Insuffisance aortique
- b. Insuffisance mitrale
- c. **Rétrécissement mitral**
- d. Canal de Botal ouvert
- e. Communication interventriculaire

138 **Q: Quelle maladie congénitale doit être recherchée lors de l'apparition d'un iléus méconial chez un nouveau-né ?**

- a. Déficit en α 1-antitrypsine
- b. Galactosémie

- c. Maladie de Gilbert
- d. Fibrose kystique

139 Q: Quel est l'antiémétique recommandé par les directives pour la prévention des nausées en cas de chimiothérapie hautement émétisante ?

- a. Antagoniste de la 5-hydroxy-tryptamine-3
- b. Anticholinergique
- c. Antihistaminique H1
- d. Prokinétique

140 Un nourrisson de six semaines, qui s'est développé normalement jusqu'à présent, commence à vomir violemment après chaque repas. Il présente une alcalose métabolique croissante.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Syndrome adrénogénital
- b. Insuffisance corticosurrénale congénitale
- c. Diabète de type 1 débutant
- d. Hyperthyroïdie
- e. Sténose hypertrophique idiopathique du pylore

141 Vous travaillez aux urgences. On vous présente une gazométrie montrant les paramètres suivants : pH 7.2, pCO₂ 17 mmHg, HCO₃ 7 mmol/l, Na 139 mmol/l, K 6.3 mmol/l, Cl 114 mmol/l. (normes : pH 7.35-7.45, pCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/l, Na 135-145 mmol/l, K 3.5-4.6 mmol/l, Cl 98-110 mmol/l)

Q: Dans le cadre du diagnostic différentiel, quelle est l'étape suivante à effectuer dans les examens biologiques ?

- a. Calcul du trou osmolaire plasmatique
- b. Calcul du trou anionique plasmatique
- c. Calcul du trou anionique urinaire

142 Vous constatez chez un patient une incapacité massive à nommer des objets. Cependant, un examen plus approfondi montre que le patient parvient à nommer les objets par la palpation.

Q: De quel syndrome neurologique s'agit-il ?

- a. Aphasie de conduction
- b. Aphasie sensorielle
- c. Stéréoagnosie
- d. Agnosie visuelle

143 Vous parlez à un ouvrier spécialisé de 55 ans qui vous demande la prescription d'un somnifère. Le patient rapporte des cauchemars récurrents dont il se réveille en nage, avec de fortes palpitations et une peur panique. Les rêves ont pour thème l'accident mortel d'un collègue de travail auquel le patient a assisté. Pendant la journée, le patient a de gros problèmes de concentration, le soir il boit de l'alcool pour rendre la nuit plus supportable.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Agraphie
- b. Amnésie
- c. Anosognosie
- d. Trouble de l'adaptation
- e. Aphasie
- f. État de stress post-traumatique
- g. Prosopagnosie

144 Chez un patient de 49 ans, on établit une anamnèse avec examen de la mémoire. À l'hétéro-anamnèse, sa femme fait état d'épisodes dépressifs occasionnels et d'une dépendance à l'alcool de longue date. On remarque que le patient est capable de raconter de manière fluide et cohérente ses expériences de la journée dans le service hospitalier, qui ne se révèlent inventées que lorsqu'il les raconte à nouveau ou lorsque la personne qui l'écoute a connaissance des procédures du service.

Q: De quoi s'agit-il sur le plan psychopathologique ?

- a. Amnésie antérograde
- b. Aphasie
- c. Confabulations
- d. Amnésie rétrograde

145 Q: Quel est le médicament de premier choix en cas de syndrome de Guillain-Barré aigu ?

- a. Cortisone
- b. Cyclophosphamide
- c. Interféron bêta
- d. Azathioprine
- e. Immunoglobulines

146 Après une maladie fébrile avec présence d'infiltrats pulmonaires à la radiographie, un patient commence à développer une opacité pleurale.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Infarctus pulmonaire hémorragique
- b. Empyème pleural
- c. Carcinose pleurale
- d. Pleurésie dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde

147 Q: Quel est le traitement de premier choix du cancer broncho-pulmonaire à petites cellules (extensive disease) ?

- a. Chimiothérapie/radiothérapie néoadjuvante suivie d'une résection
- b. Chimio-immunothérapie
- c. Radiothérapie
- d. Résection de la tumeur
- e. Polychimiothérapie

148 Q: Quel type histologique de carcinome pulmonaire se développe en grande partie indépendamment du tabagisme ?

- a. Adénocarcinome
- b. Carcinome broncho-pulmonaire à grandes cellules
- c. Carcinome broncho-pulmonaire à petites cellules
- d. Carcinome épidermoïde

149 Vous participez à une mission médicale dans une zone de conflit. En raison de la crise, l'alimentation se compose principalement de riz poli. Outre des maladies infectieuses, les patients présentent des troubles neurologiques, des insuffisances cardiaques et des œdèmes.

Q: La carence en quelle vitamine en est la plus probablement responsable ?

- a. Biotine
- b. Nicotinamide
- c. Acide pantothénique
- d. Riboflavine
- e. **Thiamine**

150 Q: Existe-t-il des situations dans lesquelles une intervention chirurgicale, p. ex. le traitement chirurgical d'une fracture proximale du fémur, peut être effectuée sans que le patient soit informé ?

- a. Non, en principe, aucune intervention ne peut être effectuée sans que le patient soit informé.
- b. Oui, en principe, toute intervention peut être effectuée sans que le patient soit informé.
- c. Oui, une intervention à faible risque peut être effectuée sans que le patient soit informé.
- d. **Oui, une intervention d'urgence sur un patient incapable de donner son consentement peut être effectuée sans que le patient soit informé, à condition que cela corresponde à la volonté présumée du patient.**
- e. Il n'y a pas de réglementation explicite à ce sujet, c'est le médecin qui décide.

151 Une femme de 40 ans a été soumise à un examen cardiologique en raison de palpitations intermittentes. Les résultats ne montrent aucune anomalie des fonctions cardiaque et valvulaire. Le cathétérisme cardiaque a permis d'exclure une maladie coronarienne. Cependant, l'échocardiographie et le cathétérisme cardiaque ont révélé qu'une tumeur pédiculée attachée au septum interauriculaire et oscillant jusqu'à la valve mitrale pouvait être à l'origine des troubles présentés par cette patiente.

Q: De laquelle des maladies suivantes s'agit-il le plus probablement ?

- a. Végétation bactérienne d'une endocardite de la valve mitrale
- b. Lipome
- c. **Myxome**
- d. Rhabdomyosarcome

152 Q: Laquelle des malformations cardiaques ci-dessous est particulièrement fréquente chez le nouveau-né atteint du syndrome de Down ?

- a. Transposition des gros vaisseaux
- b. Tétralogie de Fallot
- c. Communications atrio-ventriculaires
- d. Atrésies tricuspidiennes
- e. Persistance du canal artériel

153 Un nouveau-né présente une microcéphalie, une surdité, une cataracte ainsi qu'une malformation cardiaque congénitale.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Syndrome d'alcoolisme fœtal
- b. Exposition fœtale à l'héroïne
- c. Toxoplasmose congénitale
- d. Infection congénitale au cytomégalo virus
- e. Syndrome de rubéole congénitale

154 Un ouvrier du bâtiment de 45 ans explique à son médecin de famille avoir été envoyé par son employeur pour un problème d'alcool. Selon le patient, il est courant de boire de l'alcool au travail, sinon celui-ci ne se passerait pas aussi bien. La quantité consommée correspond à quelques bouteilles, quantité qu'il dit bien tolérer. Il boit également un peu après le travail, pour se sentir bien. Ne voulant toutefois pas faire mauvaise impression à son employeur, il a décidé de ne boire qu'après le travail. Mais il lui semble qu'il aurait mieux fait son travail en buvant quelques bières, car maintenant ses mains tremblent. Il a déjà été menacé de licenciement s'il n'arrêtait pas sa consommation d'alcool.

Q: De quel type d'alcoolique s'agit-il ?

- a. Type alpha
- b. Type bêta
- c. Type gamma
- d. Type delta
- e. Type epsilon

155 Une femme de 32 ans se présente pour une fièvre atteignant 39.6 °C depuis deux jours, une dysurie et une pollakiurie ainsi que de fortes douleurs au flanc gauche. À l'examen clinique, on note une douleur à la percussion de la loge rénale gauche.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Kystes rénaux
- b. Lithiase urétérale
- c. **Pyélonéphrite aiguë**
- d. Rupture rénale
- e. Tumeur rénale

156 Après une collision par l'arrière avec traumatisme abdominal fermé, une patiente de 28 ans se plaint de douleurs pelviennes et d'hématurie macroscopique. L'échographie abdominale révèle la présence de liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Vessie neurogène
- b. **Rupture vésicale intrapéritonéale**
- c. Tamponnade vésicale
- d. Urinome

157 Un patient de 64 ans est amené aux urgences par le médecin urgentiste après un grave accident de la route. À l'admission, le patient est stable sur le plan cardiopulmonaire. Or, le tableau clinique évolue vers une situation de choc avec tachycardie, hypotension artérielle, augmentation des besoins en catécholamines et turgescence jugulaire.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. **Tamponnade cardiaque**
- b. Infarctus du myocarde
- c. Embolie pulmonaire sévère
- d. Pneumothorax sous tension
- e. Choc hypovolémique

158 Un garde forestier de 29 ans souffre de céphalées, d'état d'abattement et de fièvre depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, il a été victime d'une crise convulsive généralisée suivie d'une perte de connaissance.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Ischémie cérébrale
- b. Hémorragie sous-arachnoïdienne

- c. Hématome épidural
- d. Encéphalite

159 Depuis l'arrivée du deuxième enfant, qui a maintenant 1 an, les conflits dominent la vie quotidienne de la famille. L'aînée de 6 ans est agressive et refuse de communiquer avec sa mère. La mère est dépassée par la situation. Le père travaille par roulement et se retire de la vie quotidienne familiale. Par conséquent, il y a de plus en plus de conflits entre les parents.

Q: Quelle est l'approche thérapeutique de premier choix dans ce cas ?

- a. Psychothérapie analytique pour enfants et adolescents
- b. Training autogène
- c. Thérapie familiale
- d. Approche centrée sur la personne
- e. Thérapie de couple
- f. Entraînement aux activités de la vie quotidienne
- g. Thérapie comportementale

160 Une patiente somnolente de 65 ans, hautement fébrile, se présente aux urgences 4 jours après sa dernière chimiothérapie avec une pression artérielle de 85/42 mmHg, une fréquence cardiaque de 122/min, une fréquence respiratoire de 30/min et une saturation périphérique de 90 %. La gazométrie artérielle après pose d'un cathéter artériel montre : pH 7.32, pCO₂ 24 mmHg, HCO₃ 15 mmol/l, lactate 9 mmol/l, glucose 13.3 mmol/l, Na 133 mmol/l, K 4.2 mmol/l, Ca 1.20 mmol/l, Cl 105 mmol/l. Les premières valeurs venant du laboratoire d'urgence montrent : créatinine 283 mol/l, urée 35 mmol/l. (normes : pH 7.38-7.44, pCO₂ 37-43 mmHg, HCO₃ 21-28 mmol/l, lactate 0.6-1.7 mmol/l, glucose 4.2-5.6 mmol/l, Na 135-145 mmol/l, K 3.5-4.5 mmol/l, Ca 2.15-2.65 mmol/l, Cl 95-105 mmol/l, créatinine < 115 mmol/l, urée 3.6-7.1 mmol/l)

Q: Quelle est la meilleure étape thérapeutique ?

- a. Remplacement liquidien par cristalloïdes (1-2 l pendant les 1-2 premières heures) et début d'une insulinothérapie à faible dose (p. ex. : 0.05-0.1 U/kg PC/h i.v.) dans le but de réduire la glycémie de 3 à 6 mmol/l/heure, sous surveillance du potassium sérique
- b. Début d'un remplacement liquidien cristalloïde en même temps que l'administration intraveineuse de bicarbonate, sous surveillance du potassium sérique, dans le but d'augmenter le bicarbonate sérique à > 18-20 mmol/l

- c. Mise en place immédiate d'une voie de dialyse (p. ex. cathéter de Shaldon) et initiation d'une dialyse d'urgence
- d. Traitement par éthanol (p. ex. à 10 %) avec un taux d'éthanol cible de 1.0 à 1.5 ‰ ou traitement par fomépizole, un inhibiteur de l'alcool déshydrogénase
- e. Administration forcée d'un volume liquidien de 30-40 ml/kg de poids corporel avec une solution cristalloïde pendant les 3 premières heures et, si nécessaire, début de catécholamines